

Guia de Oportunidades para Toda a Vida 81 — Tecnólogo em informação de saúde e registrador médico

Versão: 2.0, mestre de trabalho controlado

Idioma: português brasileiro (pt-BR)

Fonte inglesa congelada: blob 321a7cac380aa12ea340325e5b1a150eb0a93f1b

Referência principal dos EUA: O*NET-SOC 29-9021.00 — Health Information Technologists and Medical Registrars

Comparação do Canadá: NOC 12111 — Health information management occupations

Comparação da Colômbia: CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria

Data da revisão: 2026-08-21

O que é esta carreira

Tecnólogos em informação de saúde e registradores médicos transformam informações clínicas e administrativas em registros, classificações, registros especializados, relatórios e sistemas de informação precisos, seguros e utilizáveis. Dependendo do cargo, podem abstrair informações de prontuários, classificar ou codificar dados, apoiar prontuário eletrônico, manter registros de doenças/tratamentos, revisar qualidade de dados, preparar relatórios, recuperar registros, apoiar procedimentos de privacidade/cibersegurança, treinar equipes e melhorar fluxos de informação em saúde.

O trabalho fica entre saúde, gestão da informação e tecnologia. Exige terminologia médica suficiente para entender a documentação, disciplina de informação para preservar registros confiáveis e julgamento técnico para reconhecer quando uma questão clínica, de codificação, privacidade ou sistema deve ser escalada.

Este guia usa **O*NET-SOC 29-9021.00 — Health Information**

Technologists and Medical Registrars como principal referência dos Estados Unidos. O Canadá tem correspondência próxima com **NOC 12111 — Health information management occupations**. A Colômbia possui correspondência direta em **CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria**.

Por que pode ser uma boa oportunidade

A ocupação dos Estados Unidos está classificada como Bright Outlook. Organizações de saúde continuam digitalizando registros, melhorando qualidade de dados, ampliando registros clínicos e analítica, aumentando

interoperabilidade, gerenciando privacidade/cibersegurança e introduzindo automação. Isso aumenta a importância de profissionais que entendam tanto informação em saúde quanto sistemas.

A rota pode começar em administração em saúde, prontuários, codificação, faturamento, admissão, apoio clínico, entrada de dados, qualidade, saúde pública, seguros, gestão documental, TI ou atendimento a pacientes.

Uma progressão realista:

apoio administrativo ou de registros em saúde → técnico/tecnólogo ou registrador de informação em saúde → especialização em codificação, registro ou qualidade de dados → analista, sistemas, documentação clínica, informática em saúde, supervisão ou gestão.

O caminho depende de educação, jurisdição, empregador, especialidade e credenciais.

Tecnólogo em informação de saúde, registrador médico, codificador, especialista de prontuários e informata em saúde não são o mesmo papel

Tecnólogo em informação de saúde

Pode atuar com:

- EHR/prontuário eletrônico;
- qualidade e validação de dados;
- relatórios;
- bancos de dados e extrações;
- implantação/atualização de sistemas;
- análise de fluxo;
- privacidade/cibersegurança;
- treinamento de usuários;
- índices e sistemas de armazenamento/recuperação.

Registrador médico

Neste contexto, “registrador” pode se referir a registros de doenças, tumores/câncer ou outros registros clínicos especializados, e não a um título médico de atendimento.

Pode:

- abstrair informações clínicas definidas;
- classificar casos conforme regras do registro;
- acompanhar casos;
- manter completude e qualidade;

- preparar estatísticas/relatórios;
- apoiar pesquisa, vigilância ou melhoria de qualidade.

Alguns registros especializados exigem formação ou credenciais específicas.

Codificador médico

Aplica sistemas de classificação e regras aprovadas à informação clínica documentada. **Codificar não é diagnosticar.** Não se deve inventar diagnóstico porque pareça clinicamente provável.

Especialista de prontuários/registros médicos

Pode concentrar-se em completude, liberação de informação, digitalização/indexação, filas documentais, correção de registros, recuperação, identidade do paciente e controles administrativos.

Especialista em informática em saúde

Pode ter responsabilidade mais ampla por sistemas clínicos, desenho de fluxo, padrões, análise, interoperabilidade, implantação e estratégia tecnológica. Alguns cargos exigem formação técnica mais avançada.

Autoridade e limites clínicos/profissionais

Um cargo de informação em saúde **não** autoriza automaticamente a pessoa a:

- diagnosticar doença;
- prescrever ou recomendar tratamento;
- interpretar de forma independente um achado clínico para atendimento;
- inventar ou inferir diagnóstico para completar cobrança ou registro;
- alterar documentação-fonte do profissional clínico fora do fluxo aprovado de correção/emenda;
- atribuir código sem suporte na documentação e regras aplicáveis;
- excluir informação clinicamente relevante porque é inconveniente;
- divulgar informação de saúde protegida apenas porque consegue acessá-la;
- determinar sozinho conformidade legal/regulatória sem atribuição formal;
- decidir retenção/destruição ou remover legal hold sem autoridade;
- projetar arquitetura de cibersegurança de produção sem responsabilidade atribuída;
- usar informação real protegida em portfólio público ou IA não aprovada;
- alegar certificação, licença, registro ou acreditação não obtida.

Se a documentação estiver incompleta, conflitante ou ambígua, use o processo aprovado de consulta ao profissional clínico, equipe de codificação ou registro. O*NET reconhece expressamente a consulta a médicos ou outros quando códigos/diagnósticos estão conflitantes, ausentes ou pouco claros.

Ciclo de vida da informação em saúde

1. Capturar a informação-fonte

Pode vir de notas clínicas, exames, laboratório, imagem, ordens, cirurgia/procedimentos, medicamentos, admissão/alta, dados demográficos, faturamento, dispositivos/interfaces, saúde pública, informação do paciente ou registros externos.

Saiba qual fonte é autorizada e se está completa.

2. Confirmar identidade do paciente e do registro

Erros de identidade podem criar riscos clínicos e de privacidade. Siga procedimentos aprovados e revise nome, aliases, nascimento, número do prontuário, encontro/conta, endereço, duplicatas, fusões, unidade e datas de atendimento.

Não una nem altere identidades fora da autoridade atribuída.

3. Abstrair e classificar

Abstração significa extrair informação definida do prontuário segundo dicionário de dados, regra de registro, regra de codificação ou requisito de relatório.

Exige definições consistentes, rastreabilidade, contexto correto, distinção entre fato documentado e interpretação, manejo adequado de ausências e escalonamento de ambiguidade.

4. Validar qualidade de dados

A qualidade inclui:

- completude;
- precisão;
- consistência;
- oportunidade;
- validade;
- unicidade;
- identidade correta;
- codificação/classificação correta;
- rastreabilidade à fonte;

- acesso/segurança corretos.

Campo preenchido não significa campo correto.

5. Armazenar e proteger

Siga regras aprovadas para EHR/banco, indexação, status, histórico de versão/emenda, permissões, retenção, backup/recuperação, legal hold, auditoria e liberação de informação.

6. Recuperar e liberar informação

Antes da liberação, confirme identidade, autoridade/autorização, fluxo de release of information, paciente correto, período/tipo documental, escopo mínimo/aprovado, redação, canal seguro e registro da liberação.

7. Analisar e relatar

Pode preparar censos, relatórios de registros, métricas de qualidade, tendências de codificação/documentação, completude, dashboards, estatísticas de doenças/tratamentos e exceções de dados.

Diferencie apresentar dados de emitir conclusão clínica.

Codificação clínica e integridade documental

A codificação pode usar sistemas de diagnóstico/procedimento, DRG e ferramentas encoder. Regras variam por país, pagador, especialidade e ambiente.

Princípios:

- codifique a partir da documentação autorizada;
- aplique a norma/versão exigida;
- não crie diagnóstico ausente;
- preserve rastreabilidade;
- consulte informação conflitante ou pouco clara;
- diferencie validação clínica de validação de codificação;
- não altere documentação para obter reembolso preferido;
- escale suspeita de fraude ou pressão indevida.

Registros clínicos especializados

Registros podem acompanhar câncer/tumores, trauma, implantes, doenças, procedimentos, resultados ou outras populações.

Compreenda critérios de inclusão/exclusão, case finding, abstração, follow-up, classificação/estadiamento, fontes obrigatórias, edições de qualidade, duplicatas, prazos, confidencialidade e governança.

Não aplique classificação clínica fora das regras e formação exigidas pelo registro.

Sistemas de informação em saúde

Conceitos úteis:

- EHR/prontuário eletrônico;
- master patient index;
- documentação clínica;
- interfaces laboratório/radiologia;
- codificação/encoder;
- liberação de informação;
- gestão de imagens/documentos;
- software de registro;
- bancos/consultas;
- reporting/Bi;
- interoperabilidade;
- identidade/acesso;
- logs de auditoria;
- downtime/recuperação.

O tecnólogo pode apoiar testes, implantação, treinamento e melhoria, sem se tornar automaticamente DBA, engenheiro de software ou arquiteto de segurança.

Qualidade de dados: método repetível

1. identifique o elemento e fonte autorizada;
2. verifique paciente/encontro;
3. aplique definição/regra vigente;
4. capture ou valide;
5. rode edições necessárias;
6. revise ausências/conflitos;
7. consulte/escalone;
8. documente a resolução;
9. confirme impacto em sistemas/relatórios;
10. preserve evidência de auditoria.

Não “limpe” dados removendo valores incomuns porém legítimos.

Privacidade e confidencialidade

Boas práticas:

- acessar apenas registros necessários;

- nunca usar conta de outra pessoa;
- proteger senhas e MFA;
- bloquear estação ao se afastar;
- verificar destinatários;
- evitar conversas públicas sobre pacientes;
- usar armazenamento/transmissão aprovados;
- reportar envio incorreto;
- seguir regras de papel/impressão/descarte;
- evitar downloads/exportações desnecessários;
- não consultar prontuários por curiosidade.

A lei varia por jurisdição. Siga a lei aplicável e a política; este guia não é aconselhamento jurídico.

Cibersegurança em informação de saúde

Saúde é alvo frequente de phishing, roubo de credenciais, ransomware e exfiltração.

Práticas:

- reconhecer mensagens suspeitas;
- usar MFA;
- reportar prompts MFA inesperados;
- verificar solicitações incomuns de grandes exportações;
- usar dispositivos/redes aprovados;
- não desativar controles de segurança;
- evitar USB/nuvem pessoal não autorizados;
- seguir contingência em incidentes;
- reportar acesso não autorizado.

Ser tecnicamente possível exportar não significa estar autorizado.

Uso responsável de IA e automação

Fluxos podem usar OCR, computer-assisted coding, NLP, regras, deduplicação, modelos preditivos e IA generativa.

Automação aprovada pode ajudar a extrair campos candidatos, detectar documentação ausente, sugerir classificações, identificar duplicatas, criar dados sintéticos ou apoiar treinamento.

Para informação real:

- use apenas sistemas e classes de dados aprovados;
- preserve rastreabilidade;
- verifique extração/codificação/resumo;

- nunca deixe IA inventar diagnóstico ou fato clínico;
- mantenha aprovação humana quando exigida;
- monitore erro sistemático e viés;
- proteja dados de saúde;
- preserve logs;
- escale resultado inseguro ou inexplicável.

O NIST AI RMF é orientação voluntária de gestão de risco e o perfil de IA generativa cobre riscos específicos. Não substituem governança clínica, de codificação, privacidade, segurança ou legal.

Acessibilidade e inclusão

Sistemas e documentos devem apoiar usuários com deficiência quando aplicável. Princípios: teclado, rótulos significativos, contraste legível, foco visível, mensagens de erro úteis, ordem lógica, documentos acessíveis, tecnologia assistiva, legendas/transcrições e não depender só de cor.

Checagem automática não prova conformidade legal completa.

Caminho nos Estados Unidos

O*NET classifica a ocupação em **Job Zone Three — Medium Preparation Needed**. Formação vocacional, experiência relacionada ou associate degree são comuns, com um a dois anos de treinamento no trabalho/informal.

Experiência útil inclui tecnologia da informação em saúde, prontuários, codificação, administração em saúde, registros, dados/análise, apoio clínico ou TI em saúde.

Registered Apprenticeship

O*NET lista títulos aprovados de exemplo:

- Clinical Documentation Improvement Specialist;
- Health Information Technologist (Nof);
- Tumor Registrar.

Título aprovado não garante vaga atual em cada localidade.

WIOA

CareerOneStop ajuda a localizar programas elegíveis WIOA. Confirme elegibilidade individual e reconhecimento da credencial.

Salários e projeção dos Estados Unidos

Dados nacionais O*NET/BLS 2025 para **29-9021.00**:

Percentil	Anual	Por hora
10	\$39,830	\$19.15
25	\$48,940	\$23.53
Mediana	\$68,020	\$32.70
75	\$95,630	\$45.98
90	\$117,420	\$56.45

Projeção 2024-2034:

- emprego 2024: **41,900**;
- emprego projetado 2034: **48,100**;
- crescimento **15%**;
- **3,200 vagas anuais projetadas.**

Contexto não governamental de título relacionado

Indeed reportou aproximadamente **\$21.15/hora** para **Health Information Technician**, com **701 salários**, atualizado em **31 de julho de 2026**.

É estimativa de título relacionado, possivelmente mais júnior/estreito, e não substitui a série oficial O*NET/BLS.

Sinais atuais de software nos EUA

O*NET 2025:

- Microsoft Office **12%**;
- Excel **8%**;
- Epic Systems **4%**;
- Outlook **4%**;
- Word **2%**;
- PowerPoint **2%**;
- MEDITECH **1%**;
- Access **1%**.

Também há EHR, codificação, SQL/bancos, documentos, OCR e analítica. Aprenda conceitos transferíveis.

Caminho no Canadá

Job Bank identifica **NOC 12111 — Health information management occupations**.

Requisitos atuais: **diploma reconhecido de dois anos** em tecnologia de registros de saúde ou gestão de informação em saúde.

Profissionais são elegíveis ao exame nacional da **Canadian Health Information Management Association**, que **pode ser exigido por empregadores**.

Registros atuais do Job Bank indicam que a ocupação **não é regulamentada no Canadá**. Mesmo assim, empregadores podem exigir certificação.

Salários nacionais atualizados em 19 de novembro de 2025:

- baixo **C\$22.00/hora**;
- mediana **C\$30.51/hora**;
- alto **C\$46.19/hora**.

Canada.ca ajuda a localizar formação reconhecida e apoio estudantil. Verifique se o programa atende expectativas de empregador/certificação.

Caminho na Colômbia

CUOC 32520 — Técnicos en documentación sanitaria

Correspondência ocupacional direta. Denominações relevantes incluem Administrador de información de salud, Administrador de registros de salud, Analista de registros médicos, Auxiliar de codificación clínica, Auxiliar de información de salud, Auxiliar de registros médicos, Supervisor de auxiliares de registros en salud, Supervisor de unidad de registros médicos, Técnico de información de salud, Técnico de información sanitaria, Técnico de registro de enfermedades e Técnico de registros médicos.

Funções incluem índices e armazenamento/recuperação, processamento de registros/admissões, informação para vigilância, pesquisa, faturamento/custos/melhoria e revisão de completude, precisão e conformidade.

OCUPACOL não fornece aqui série salarial estatisticamente representativa adequada para uma afirmação nacional controlada. Não invente uma.

SENA — Apoyo administrativo en salud

SENA Betowa lista **Apoyo administrativo en salud** como programa **Técnico de 2,640 horas**.

Competências relevantes incluem admissão conforme normas de saúde, afiliações, registro de informação conforme norma/procedimento e uso de ferramentas de informação.

É uma base útil, não equivalência automática a todas as credenciais HIM, codificação ou registro. Vagas, locais e turmas mudam.

América Latina e Caribe

O observatório da OIT/Cinterfor ajuda a identificar instituições nacionais de formação profissional. Confirme diretamente programa, credencial, admissão, reconhecimento, modalidade e custo.

Portfólio sintético: nunca use dados reais de pacientes

Use dados totalmente sintéticos ou públicos não identificáveis.

Exemplos:

1. auditoria sintética de completude de prontuários;
2. dicionário de dados de registro fictício;
3. exercício de duplicidade sintética;
4. fluxo de consulta de documentação/codificação;
5. dashboard de qualidade fictício;
6. checklist de release of information;
7. mapa de fluxo EHR;
8. matriz de acesso;
9. fila fictícia de follow-up;
10. árvore de decisão de incidente de privacidade/cibersegurança.

Não use nomes reais, números reais de prontuário, datas de serviço reais ligadas a pessoas, screenshots de produção ou dados protegidos sem autorização explícita e legal.

Evidências para currículo

Pode demonstrar melhoria de completude, qualidade de codificação/registo, validação, identidade do paciente, backlog, EHR, relatórios, treinamento, release of information, privacidade/cibersegurança, auditoria, testes e resolução de queries.

Use somente métricas reais e comprováveis.

Preparação para entrevista

Prepare respostas para:

- o que fazer se a documentação não sustenta o código;
- como resolver documentação conflitante;
- como proteger informação sensível;
- o que define qualidade de dado de saúde;
- como validar uma abstração;
- como prevenir pacientes duplicados;
- experiência com EHR;

- como responder a pedido incomum de grande exportação;
- como validar IA/codificação assistida;
- como distinguir codificação de diagnóstico.

Boa resposta enfatiza fonte, regra, verificação e escalonamento.

Perguntas para o empregador

Pergunte por EHR/registo/codificação, credenciais obrigatórias/preferidas, padrões, queries clínicas, métricas, responsável por privacidade/release, acesso, contingência/ciberincidentes, IA aprovada, revisão humana, treinamento e progressão.

Primeiros 30 dias

Dias 1-5

- aprender políticas de registros/privacidade;
- entender identidade do paciente;
- aprender EHR/registo/codificação;
- identificar fontes;
- aprender queries/escalonamento;
- entender acesso/liberação.

Dias 6-15

- abstrações/revisões supervisionadas;
- edições de qualidade;
- recuperação/liberação;
- duplicatas;
- auditoria/histórico;
- padrões aplicáveis.

Dias 16-30

- melhorar precisão e prazo;
- identificar problemas recorrentes;
- aprender ferramenta de relatório/consulta;
- participar de revisão supervisionada;
- pedir feedback com métricas reais.

Plano de 90 dias

Mês 1: registros, privacidade, terminologia, identidade e EHR.

Mês 2: classificação, registros, abstração, queries e qualidade.

Mês 3: SQL/consultas, reporting, testes, fluxos, interoperabilidade, governança de IA e segurança.

Checklist prático de informação em saúde

Antes:

- ☐ Paciente/encontro correto.
- ☐ Fonte autorizada confirmada.
- ☐ Documentação necessária presente.
- ☐ Norma/versão/fila correta.

Durante:

- ☐ Sem inferência clínica não suportada.
- ☐ Regras de codificação/abstração aplicadas.
- ☐ Ausências/conflitos consultados ou escalados.
- ☐ Rastreabilidade preservada.
- ☐ Confidencialidade mantida.

Antes de concluir:

- ☐ Edits obrigatórios revisados.
- ☐ Status do registro correto.
- ☐ Evidência de query/auditoria registrada.
- ☐ Encaminhamento de relatório/liberação concluído.

Checklist de privacidade/liberação

- ☐ Identidade do solicitante verificada.
- ☐ Autorização/autoridade confirmada.
- ☐ Paciente/período corretos.
- ☐ Escopo mínimo/aprovado aplicado.
- ☐ Redação revisada quando necessária.
- ☐ Canal seguro usado.
- ☐ Liberação registrada.
- ☐ Nenhuma cópia não autorizada mantida.

Checklist de IA/automação

- ☐ Ferramenta aprovada para a classe de dados.
- ☐ Informação protegida tratada conforme autorização.
- ☐ Rastreabilidade mantida.
- ☐ Saída de IA/OCR/codificação verificada.
- ☐ Nenhum fato clínico inventado.
- ☐ Aprovação humana necessária concluída.
- ☐ Erros sistemáticos/exceções revisados.
- ☐ Evidência de auditoria preservada.

Fontes para verificar antes de decisões importantes

- O*NET detalhes: <https://www.onetonline.org/link/details/29-9021.00>
- O*NET resumo: <https://www.onetonline.org/link/summary/29-9021.00>
- O*NET Job Zone: <https://www.onetonline.org/skills/zone/29-9021.00>
- O*NET/BLS salários: <https://www.onetonline.org/link/localwages/29-9021.00>
- O*NET/BLS tendências: <https://www.onetonline.org/link/localtrends/29-9021.00>
- O*NET software demandado: <https://www.onetonline.org/link/demand/29-9021.00>
- O*NET hot technologies: https://www.onetonline.org/link/hot_tech/29-9021.00
- CareerOneStop WIOA: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- Indeed Health Information Technician: <https://www.indeed.com/career/health-information-technician/salaries>
- Canada Job Bank resumo: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/25618/ca>
- Canada Job Bank requisitos: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/25618/ca>
- Canada Job Bank salários: <https://www.jobbank.gc.ca/wagereport/occupation/25618>
- Canada treinamento: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- OCUPACOL CUOC 32520: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/32520>
- SENA Apoyo administrativo en salud: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/apoyo-administrativo-en-salud?location=57011001&modality=P&offertype=open&programId=212936>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST perfil de IA generativa: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- Section508.gov: <https://www.section508.gov/create/>

Limite de garantia

Este guia fornece informação educacional e de planejamento de carreira em caráter geral. Não é aconselhamento médico, de codificação, jurídico, de

privacidade, cibersegurança, retenção, financeiro, trabalhista, migratório ou regulatório. Não certifica competência clínica, precisão de codificação, registro profissional, licença, conformidade de privacidade, acessibilidade, cibersegurança nem qualidade de tradução.

Requisitos variam por empregador, jurisdição, especialidade e órgão de credenciamento. Não há garantia de emprego, renda, admissão, financiamento, certificação, licenciamento ou promoção.

Autor, assistência de IA e licença

Criado e dirigido por **Alberto “Al” Leiva**. O ChatGPT apoiou pesquisa atual, organização, edição, apoio à tradução e preparação documental sob direção do autor. O autor permanece responsável pelas decisões editoriais e de publicação.

Salvo indicação diferente, este material é licenciado sob **CC BY-NC-SA 4.0**.